



جامعة قسنطينة 3
UNIVERSITE DE
CONSTANTINE 3



Université Constantine 3 Salah Boubenider
Faculté de médecine

Département de médecine

Module de sémiologie 4 UEI : Appareil digestif

3^{ème} année médecine

LES ICTERES

Dr F.Touati
Service de médecine interne
CHU Dr Benbadis

Plan du cours

I/ Généralités : A/Définition

B/Mécanismes de l'ictère :

Rappel physiopathologique

Ictère par hyper bilirubinémie non conjuguée

Ictère par hyper bilirubinémie conjuguée

II/ Etude sémiologique:

1- Diagnostic positif

2- Diagnostic différentiel

3- Conduite du diagnostic étiologique

4- Etiologies : Des ictères à bilirubine non conjuguée

Des ictères à bilirubine conjuguée

5- Explorations

III/ Conclusion

Objectifs du cours :

- Savoir reconnaître un ictère cliniquement et savoir prescrire en fonction des données anamnestiques et cliniques les explorations nécessaires.

- Connaître les principales étiologies des ictères choléstatiques et non choléstatiques.

I/ Généralités :

A/Définition :

L'ictère est une coloration jaune de la peau et des muqueuses due à une augmentation de la concentration dans le sang de la bilirubine (Brb) ou bilirubinémie.

C'est un motif de consultation alarmant pour le patient qui relève de plusieurs étiologies et la conduite à tenir dépend du caractère conjugué ou non de la bilirubinémie.

L'hyper bilirubinémie s'accompagnera en fonction de l'étiologie de différents symptômes digestifs et d'autres extra-digestifs

B/ Mécanismes de l'ictère :

B-1/ Rappel physiopathologique :

La plus grande partie de la Brb est produite lors de la dégradation des GR → sous forme de Brb non conjuguée, elle se lie à l'albumine dans le sang avant d'être transportée vers le foie où elle est captée par les hépatocytes et sera conjuguée à l'acide glucuronique (grâce à l'UDP glucuronyl Transférase) en Brb conjuguée, c'est sous cette forme qu'elle est excrétée dans la bile au niveau du duodénum.

Dans l'intestin, les bactéries métabolisent la Brb → Urobilinogène (Couleur des urines)

Une partie de l'urobilinogène est éliminée et une autre est réabsorbée, captée par les hépatocytes, re métabolisée, et ré excrétée dans la bile (cycle entéro-hépatique) sous forme de stercobilinogène (aspect des selles)

B-2/Les conséquences de la cholestase :

- **Sels biliaires** vont s'accumuler dans la circulation et seront responsables d'un prurit et seront éliminés dans les urines → urines mousseuses

- Absence de digestion des graisses : **stéatorrhée**

- **Carences en vitamines liposolubles** (vit K)

- Cholestérol: s'accumule dans le secteur systémique et va donner des **xanthomes** sous cutanées si cholestase chronique

B-3/ Mécanisme de l'hyper bilirubinémie non conjuguée :

Provoquée par 1 ou plus des troubles suivants:

- Augmentation de la production : secondaire à une hémolyse importante

Hyperhémolyse (pathologique) associe : hyper-réticulocytose, anémie, baisse l'haptoglobine

- Défaut au niveau du métabolisme :

- Diminution de la captation hépatique
- Diminution de la conjugaison : déficit enzymatique héréditaire totale: maladie de Crigler- Najjar ou partiel: maladie de Gilbert.

B-4/ Mécanisme hyper bilirubinémie conjuguée : Anomalies de l'évacuation de la Brb :

➤ Défaut de l'excrétion biliaire par l'hépatocyte soit héréditaire : maladie de Dubin Johnson et syndrome de Rotor ou acquis: hépatite virale

➤ Au niveau des canalicules biliaires: **Cholestase intra-hépatique**: hépatites virale et médicamenteuse...

➤ Au niveau des voies extra-hépatiques: **Cholestase extra hépatique** obstacle au niveau du cholédoque: lithiases ou compression du pancréas (tumeur, adénopathie...)

II/ Etude sémiologique :

1- Diagnostic positif:

Le diagnostic est clinique à l'inspection : Rechercher la coloration jaune des téguments et des muqueuses (sclérotiques, conjonctives, muqueuse jugale...)

Parfois le début commence par un sub-ictère au niveau des sclérotiques, discret à rechercher à la lumière du jour

Selon l'intensité de l'ictère ; on parle de :

- Sub-ictère : Taux de bilirubine entre **15 et 30 mg/L**.
- Ictère franc: Taux de bilirubine **> 30mg /L**
- Ictère très intense (brun verdâtre) au maximum « bronze florentin » **Brb : 300-400 mg/L**.

2- Diagnostic différentiel:

- Peau colorée par hypercaroténémie
- Pâleur de certaines anémies

Le dosage de la bilirubinémie permettra de faire le diagnostic

3- Conduite du diagnostic étiologique:

3-a- Interrogatoire :

- Age et sexe : oriente vers certaines étiologies :
Hépatite virale : >>> adolescent + adulte jeune.
Hépatite auto-immune: les femmes jeunes++, La cholangite sclérosante : Homme +++
- Enfants : déficit enzymatique
- Sujet âgé : cancer +++mais les tumeurs s'observent également chez des adultes
- Antécédents Médicaux : d'ictère spontanément résolutif, cancer, transfusion, maladie auto-immune, lithiases biliaires, ou de soins dentaires (6 semaines à 6 mois précédant l'ictère.
- Prise médicamenteuse : contraceptifs oraux, Azathioprine, certains antibiotiques...
- Antécédents familiaux d'ictère.
- Profession : Exp. Profession de santé ont un risque plus élevé : hépatite virale B et C
- Ictère: mode de début progressif ou brutal, date de début,
- Phase pré-ictérique est très importante : Prodromes: asthénie, prurit...
- Signes accompagnateurs: prurit, coloration des selles, aspect des urines...
Rechercher la triade classique: céphalée-urticaire-arthralgies → de l'hépatite virale
- Autres signes digestifs: douleurs abdominales, nausées, vomissements, hémorragie digestive
- Signes généraux: amaigrissement, fièvre, anémie, un prurit
- Prise de toxique, notion d'injection, Éthylisme (à quantifier en gramme/jour), champignons toxiques, certaines plantes...

3-b/ Examen clinique:

- De la peau et muqueuse: rechercher un sub-ictère à jour frisant ou un ictère franc
- Un examen général: température, poids, adénopathies, pâleur de l'anémie,
- Rechercher des signes associés qui vont nous orienter vers l'origine de l'ictère :
angiomes stellaires, œdème des membres inférieurs, hémorragie, syndrome hémorragique cutané-muqueuse → hépatopathie chronique,
Prurit→ cirrhose biliaire...
- Aspect des selles et des urines
- Examen de l'appareil digestif: inspection abdominale : recherche d'une circulation veineuse collatérale (CVC), distension abdominale
- Examen de l'hypochondre droit:
Mesure de flèche hépatique → hépatomégalie (HPM) et examen du bord du foie → cirrhose, rechercher une vésicule palpable
Signe de Murphy → cholécystite.
- Recherche d'une splénomégalie + ascite en cas d'hypertension portale (HTP)

3-c/ Bilan biologique:

- Bilirubine: directe et indirecte: Pour orienter le diagnostic étiologique
- NFS et taux de réticulocytes : étiologies
- Bilan hépatique : ASAT, ALAT, Gamma GT, Ph Alcalines, 5'Nucléotidase
- Bilan infectieux : sérologies virales,

Au terme de ces examens certains éléments nous orientent déjà :

	Ictère à Brb NC	Ictère à Brb C
Ictère	+	+
Urines	Clares	Foncées, mousseuses
Selles	Normales	Décolorées
Prurit	Non	Parfois (selon les causes)
Tests hépatiques	normaux	anormaux

4/ Les étiologies :

4- 1/Ictère à bilirubine libre (non conjuguée) :

- Les ictères à Brb non conjuguée sont surtout liés à une **augmentation de la destruction des globules rouges (hémolyse)**

➤ **Ictère hémolytique chronique:** Sub-ictère, selles foncées, urines claires, sans prurit
Splénomégalie, Pâleur cutanéomuqueuse:

Biologie: Brb indirecte élevée < 50 mg, Anémie, Augmentation du taux de réticulocytes
LDH et Haptoglobine seront élevés

- **Ictère hémolytique aigue:** douleur lombaire, fièvre, oligurie, émission d'urine rouge
Porto, Exp - Ictère apparaissant suite à une erreur transfusionnelle.
- Déficit de l'enzyme G6PD responsable d'une hémolyse lors de la

consommation de fèves= Favisme

- Liés à la **diminution de la conjugaison de la bile** au niveau hépatique (**ictère non hémolytique**) Chez les enfants : ictère du nouveau né (immaturité), Syndrome de Crigler Najjar et chez l'adulte : Maladie de Gilbert

4-2/Ictère à bilirubine conjuguée

La cholestase : la **diminution ou arrêt de la sécrétion de la bile** est la cause, la plus fréquente des ictères à Brb conjuguée.

4-2-A/ Anomalies au niveau des canalicules :

- **Ictère des cirrhoses** : Poussée d'hépatite aigue ou évolution de la maladie.

- Examen du foie.
- Rechercher les signes d'HTP.
- Angiomes stellaires.
- Compléter l'examen par l'échographie, la biopsie hépatique, la fibroscopie digestive haute

- **Ictère cytolytique:**

- Hépatite virale aigue (notion de contagé) ou chronique.

{ Phase pré-ictérique: Anorexie, nausée, dégoût de la viande, syndrome grippal, asthénie
Triade de Caroli: rare migraine, urticaire et arthralgies.

{ Phase ictérique: ictère franc avec selles et urines de coloration normale, rarement HPM.

- Hépatite auto-immune +rare ; y penser chez une femme jeune, terrain auto-immun
- Hépatite médicamenteuse : peut-être cytolytique ou cholestatique.

4- 2-B/ Cholestase avec obstacle sur les voies biliaires :

La cholestase peut être due à une obstruction des canaux biliaires au niveau des gros canaux (visualisable par les techniques d'imagerie) ou au niveau des canaux de petit calibre (observables seulement par examen microscopique d'une biopsie du foie).

- L'obstruction de la voie biliaire principale est le mécanisme le plus fréquent de l'ictère :
Angiocholite: presque toujours associée à une lithiasse de la voie biliaire principale ou des gros canaux, caractérisée par une infection bactérienne de la bile et des voies biliaires
- **L'obstruction des canaux biliaires** (de petit calibre) doit être diffuse pour entraîner un ictère. Les principales causes en sont la cirrhose biliaire primitive et la cholangite.
- **Ictère lors des cancers** : par compression Pancréas, foie, ampullome Votérien
- **Ictère à Brb conjuguée sans cholestase** : Défaut de l'excrétion biliaire maladie de Dubin Johnson et syndrome de Rotor ou acquis.

4-2-C / Autres :

- **Ictère lié à des mécanismes multiples** : Fréquemment, l'ictère ne relève pas d'un seul mécanisme mais d'une conjonction de différents facteurs : Cas des cirrhoses.

5/ Explorations :

Sont nécessaires pour **définir la cause de l'ictère à Brb conjuguée**

- **L'échographie** abdominale permet de définir l'origine des obstacles à l'écoulement de la bile, le plus souvent, les lithiases, tumeurs, ADP,
- **Le scanner avec injection de produit de contraste**: Le scanner permet une meilleure caractérisation des affections du pancréas ou des lésions tissulaires susceptibles de comprimer ou d'envahir les voies biliaires.
- **L'IRM abdominale**: Certaines séquences permettent une visualisation de très bonne qualité des voies biliaires et pancréatiques sans injection de produit de contraste (bili-IRM) ou IRM hépatique pour détecter les tumeurs hépatiques
- La fibroscopie digestive haute pour rechercher des varices œsophagiennes
- **Autres** : Echo-endoscopie, Echodoppler des veines sus hépatiques, biopsie hépatique, Elastométrie (étude du parenchyme) plus rarement, la cholangiographie per rétrograde (explorer les voies biliaires)
- Les bilans biologiques : sérologie virale, bilan immunologique

III/Conclusion :

L'ictère est un motif de consultation révélant parfois une urgence : ictère cholestatique : angiocholite...

Les données de l'anamnèse et le caractère conjugué ou non de la bilirubine nous orientent déjà vers l'étiologie. Le traitement de fond est celui de l'étiologie.

Références

Précis de sémiologie RM.Hamladji 2016 Edition des OPU

Hépatogastro-entérologie R.Jian et col 2001 Edition Ellipses